MANUAL EXAUSTIVO DE PRÉ-NATAL NORMAL

Guia Completo de Condutas, Propedêutica, Fármacos e Vacinação na Gestação de Baixo Risco

Diretrizes FEBRASGO & Ministério da Saúde | Módulo de Ginecologia e Obstetrícia

1. FUNDAMENTOS, OBJETIVOS E ATRIBUTOS DO PRÉ-NATAL

A **assistência pré-natal** é o conjunto de ações de saúde voltadas à manutenção do bem-estar biopsicossocial da gestante e do feto. Embora a gestação seja um processo essencialmente fisiológico, em **5% a 20% dos casos** ocorrem complicações patológicas. Cabe ao médico obstetra/pré-natalista o domínio aprofundado das adaptações fisiológicas maternas para prevenir, diagnosticar e tratar intercorrências precocemente.

> **O TRIPÉ FUNDAMENTAL DO PRÉ-NATAL:**
> **1. Prevenção:** Orientação nutricional, imunização, suplementação e controle de fatores de risco.
> **2. Diagnóstico:** Identificação precoce de patologias materno-fetais e estadiamento do risco.
> **3. Tratamento:** Intervenção oportuna para mitigar danos e assegurar o nascimento saudável.

Impacto Epidemiológico e Econômico do Pré-Natal:

Estudos epidemiológicos demonstram que a realização de **7 ou mais consultas pré-natais** reduz drasticamente a morbimortalidade perinatal. Em contrapartida, a frequência de **4 ou menos consultas aumenta em 7 vezes o risco de óbito fetal (OF)**. Sob a ótica da saúde pública, a assistência pré-natal apresenta excelente custo-benefício: *cada dólar investido no pré-natal gera uma economia direta de US$ 1,49 no puerpério* por prevenção de complicações graves.

Os 10 Passos do Pré-Natal de Qualidade na Atenção Básica (Ministério da Saúde):

> **1. Captação Precoce:** Início do pré-natal até a 12ª semana de gestação.
> **2. Recursos Garantidos:** Acesso a profissionais, infraestrutura, insumos e testes rápidos.
> **3. Exames Oportunos:** Realização e avaliação tempestiva da rotina laboratorial e ultrassonográfica.
> **4. Espaço Coletivo:** Promoção de rodas de conversa e educação em saúde com escuta ativa.
> **5. Transporte Gratuito:** Garantia de deslocamento público para consultas e exames.
> **6. Pré-Natal do Parceiro:** Envolvimento do pai/parceiro com exames, vacinas e orientação paterna.
> **7. Acesso à Referência:** Encaminhamento ágil para pré-natal de alto risco quando indicado.
> **8. Plano de Parto:** Construção conjunta do plano de parto estimulando o parto fisiológico.
> **9. Vinculação à Maternidade:** Visita prévia da gestante ao hospital de referência do parto.
> **10. Garantia de Direitos:** Esclarecimento e proteção dos direitos legais e trabalhistas da gestante.

2. ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL E RISCO TERATOGÊNICO

A avaliação do risco gestacional é dinâmica e deve ser renovada a cada consulta. Os fatores de risco dividem-se em três pilares principais:

Categoria de Risco	Fatores de Risco Específicos	Impacto / Conduta Médico-Obstétrica
Sociodemográficos	• Idade < 17 anos ou > 35 anos • IMC prévio < 20 ou > 30 kg/m² • Tabagismo (> 10 cig/dia), álcool, drogas • Vulnerabilidade social / Risco ocupacional	Aumento do risco de cromossomopatias (Trissomia 21: 1:1444 aos 20a; 1:282 aos 35a; 1:35 aos 45a), Restrição de Crescimento Intrauterino (RCIU) e Pré-Eclâmpsia.
História Reprodutiva	• Esterilidade prévia (≥ 2 anos) • Abortamento de repetição ou Incompetência Istmocervical • Parto prematuro prévio ou RCIU anterior • Óbito fetal anterior / Malformação prévia	Vigilância intensificada da medida do colo uterino no 2ºT (20-24s), consideração de progesterona natural micronizada e rastreio genético/ultrassonográfico.
Condições Médicas Preexistentes	• Hipertensão Arterial Crônica (HAS) • Diabetes Mellitus prévio • Cardiopatias, Pneumopatias, Doenças Renais • Trombofilias, LES, SAF, Epilepsia	Encaminhamento para Pré-Natal de Alto Risco. Introdução profilática de AAS (100mg/dia) + Cálcio (1-1,5g/dia) na prevenção de Pré-Eclâmpsia.

Classificação do Risco Teratogênico da FDA e Medicamentos Contraindicados:

A prescrição farmacológica na gestação exige cautela estrita. A FDA categoriza os fármacos de A a X:

Categoria FDA	Definição do Risco Teratogênico	Exemplos Clínicos Relevantes
Categoria A	Estudos controlados em gestantes não demonstraram risco fetal no 1ºT.	Ácido Fólico, Piridoxina (Vit. B6), Levotiroxina.
Categoria B	Estudos em animais sem risco (sem estudos em humanos) ou com risco animal não confirmado em humanos.	Paracetamol, Amoxicilina, Ampicilina, Cefalosporinas, Insulina.
Categoria C	Estudos em animais mostraram teratogenia/fetotoxicidade. Usar apenas se benefício > risco.	Metildopa, Anlodipino, Fluoxetina, Omeprazol, Corticoides.
Categoria D	Evidência positiva de risco fetal humano. Usar em situações de emergência de risco de vida.	Losartana, Enalapril (iECA/BRA), Anticonvulsivantes (Carbamazepina).
Categoria X	**Contraindicação Absoluta.** Demonstração clara de anomalias fetais. Risco supera qualquer benefício.	**Isotretinoína, Estatinas, Lítio, Warfarin, Misoprostol, Talidomida, Metotrexato.**

3. DIAGNOSTICANDO A GRAVIDEZ E EXAME FÍSICO OBSTÉTRICO

O diagnóstico clínico de gravidez fundamenta-se na classificação semiológica dos sinais e sintomas:

Categoria Semiológica	Manifestações Clínicas e Sinais Epônimos	Significado / Diagnóstico
Sinais de Presunção (Sintomas Sistêmicos / Maternose)	• Amenorreia (até 14 dias) • Polaciúria, náuseas, vômitos, sialorreia • **Sinal de Hunter:** Aréola secundária de limites imprecisos (~20s) • **Tubérculos de Montgomery:** Hipertrofia sebácea areolar (~8s) • **Rede de Haller:** Aumento da venulação mamária (~16s) • **Sinal de Halban:** Lanugem no limite do couro cabeludo	Subjetivos. Refletem as adaptações hormonais maternas globais. Não confirmam gestação isoladamente.

Categoria Semiológica	Manifestações Clínicas e Sinais Epônimos	Significado / Diagnóstico
Sinais de Probabilidade (Alterações Genitais Constatadas pelo Médico)	• **Sinal de Hegar:** Amolecimento marcante do istmo uterino (~6-8s) • **Sinal de Goodell:** Amolecimento do colo (consistência de lábio) • **Sinal de Piskacek:** Assimetria uterina no local da nidação (~8s) • **Sinal de Nobile-Budin:** Preenchimento dos fórnices vaginais (~8s) • **Sinal de Osiander:** Pulsação da artéria vaginal no fundo de saco • **Sinal de Chadwick / Jacquemier:** Vagina/vulva violácea/cianótica	Objetivos genitais. Indicam fortes evidências físicas de útero gravídico e congestão pélvica.
Sinais de Certeza (Constatação Inequívoca Fetal)	• **Sinal de Puzos:** Rechaço fetal intra-amniótico ao toque (~14s) • **Ausculta de BCF:** Sonar Doppler (10-11s) ou Pinard (20-22s) • **Percepção ativa de movimentos fetais** pelo examinador (18-20s) • **Palpação de polos fetais** (Manobras de Leopold-Zweifel) • **Ultrassonografia:** Embrião com BCF presente	**Confirmação absoluta de gravidez.** Atestam a presença física e vitalidade do feto.

Cálculo da Data Provável do Parto (DPP) e Regra de Naegele:

Em mulheres com ciclos de 28 dias, a DPP equivale a 40 semanas (280 dias) a partir do primeiro dia da DUM.
• **Fórmula da Regra de Naegele:** *Somam-se 7 dias ao primeiro dia da DUM. Ao mês: somam-se 9 meses (se DUM em jan-mar) ou subtraem-se 3 meses (se DUM em abr-dez).*
• **Ajuste Ultrassonográfico:** No 1º trimestre, mede-se o Comprimento Cabeça-Nádega (CCN). Se a diferença entre a DUM e o CCN for ≥ **5 dias**, corrige-se a datação oficial pelo ultrassom.

Avaliação Nutricional (IMC Pré-Gestacional e Ganho Ponderal):

Classificação do IMC Pré-Gesta	IMC (kg/m²)	Ganho de Peso Total Recomendado	Ganho Semanal no 2º e 3º T
Baixo Peso	< 18,5	**12,5 a 18,0 kg**	0,5 kg / semana
Eutrófica (Adequado)	18,5 a 24,9	**11,5 a 16,0 kg**	0,4 kg / semana
Sobrepeso	25,0 a 29,9	**7,0 a 11,5 kg**	0,3 kg / semana
Obesidade	≥ 30,0	**5,0 a 9,0 kg**	0,2 kg / semana

Medida da Altura Uterina (AU) e Ausculta de BCF:

• **Pontos Anatômicos da AU:** Sínfise púbica (12-14s), cicatriz umbilical (20s = ~20 cm), apêndice xifoide (36s). Entre 20 e 34s, a AU em cm corresponde aproximadamente à idade gestacional em semanas.
• **Alerta da AU:** Divergência **> 3 cm** entre a AU esperada e a mensurada exige investigação ultrassonográfica imediata para afastar RCIU, oligoidrâmnio ou polidrâmnio.
• **Ausculta de BCF:** Frequência cardíaca fetal normal varia de **120 a 160 bpm**. Audível via Sonar Doppler a partir de 10-11s e via Pinard a partir de 20-22s.

4. ROTINA LABORATORIAL E ULTRASSONOGRÁFICA POR TRIMESTRE

Trimestre Gestacional	Exames Laboratoriais Obrigatórios	Condutas e Janelas de Repetição
1º Trimestre (1ª Consulta / Entrada)	• Hemograma completo • Tipagem sanguínea e Fator Rh (+ Coombs Indireto/PAI se Rh-) • Glicemia de jejum (Normal < 92 mg/dL) • VDRL/RPR (Sífilis) e anti-HIV (Testes rápidos ou sorologia) • AgHBs (Hepatite B) e Sorologia Toxoplasmose (IgG e IgM) • Urina I (EQU) e Urocultura com antibiograma • Eletroforese de Hb (se anemia crônica / negras) • Colpocitologia oncótica / Papanicolau (mesma rotina)	Glicemia de jejum ≥ 92 mg/dL no 1ºT diagnostica Diabetes Gestacional (DMG). Se VDRL+, tratar sífilis imediatamente com Penicilina Benzatina.
2º Trimestre (24 a 28 Semanas)	• **TOTG 75g (Glicemia Oral 2h):** Coletado entre 24-28s se glicemia de jejum no 1ºT foi < 92 mg/dL. • **Coombs Indireto / PAI:** Repetir mensalmente a partir da 24ª semana em gestantes Rh negativeis.	Valores de corte TOTG 75g (DMG se ≥ 1 valor alterado): • Jejum: ≥ 92 mg/dL | 1h: ≥ 180 mg/dL | 2h: ≥ 153 mg/dL. Imunoglobulina Anti-D administrada com 28s se Rh- e Coombs-.
3º Trimestre (28 a 32 Semanas / Final)	• Repetição do Hemograma, Urina I, Urocultura • Repetição do VDRL, anti-HIV, AgHBs e Toxoplasmose (se suscetível) • **Swab Anovaginal para Estreptococo do Grupo B (GBS):** Coleta única entre **35 e 37 semanas**.	GBS positivo na cultura anovaginal indica **antibioticoprofilaxia intraparto com Penicilina G Cristalina** no início do trabalho de parto.

Protocolo de Acompanhamento Ultrassonográfico (FEBRASGO):

Exame Ultrassonográfico	Janela de Idade Gestacional	Objetivos e Marcadores Principais
USG Obstétrico Transvaginal Precoce	6 a 9 semanas	Confirmar gestação tópica, viabilidade (BCF), número de embriões, corionicidade e **datação precisa pelo CCN**.
USG Morfológico de 1º Trimestre	11 a 13w + 6d	Rastreio de cromossomopatias: **Translucência Nucal (TN)**, osso nasal, ducto venoso e regurgitação tricúspide. Doppler das uterinas.
USG Morfológico de 2º Trimestre	20 a 24 semanas	Análise anatômica detalhada de todos os órgãos fetais, placenta, líquido amniótico e **medida do comprimento do colo uterino** (risco de prematuridade).
USG Obstétrico de 3º Trimestre	32 a 34 semanas	Avaliação do crescimento fetal, biometria (CC, CA, Fêmur), cálculo do Peso Fetal Estimado (PFE/percentil) e volume de líquido amniótico.

5. SUPLEMENTAÇÃO PROFILÁTICA, ESQUEMA VACINAL E CONSULTAS

Diretrizes de Suplementação Nutricional:

Suplemento	Dosagem Profilática de Rotina	Indicações Especiais / Alta Dosagem
Ferro Elementar	**40 mg de ferro elementar/dia** (200 mg de Sulfato Ferroso) do diagnóstico até o final da gestação.	Em caso de anemia instalada (Hb < 11 / Hb < 10,7 no 2ºT), elevar para **60 a 120 mg/dia de ferro elementar** até normalização.
Ácido Fólico	**400 µg/dia (0,4 mg)** profilático desde o período preconcepcional até o final da gestação.	**Alta dosagem: 4 mg/dia (ou 5 mg/dia)** na preconcepção até 12s se fatores de risco: DTN anterior, anticonvulsivantes, DM1, IMC>35.
Cálcio Elementar	**Não é universal no Brasil.** Indicado para baixa ingestão dietética e/ou alto risco de Pré-Eclâmpsia.	**1,0 a 1,5 g/dia** (da 20ª semana até o parto). Fracionar em tomadas de até 500mg. *Não administrar no mesmo horário do ferro (espaçar 2h).*

Calendário Vacinal da Gestante (SBIm / FEBRASGO):

Vacinas Recomendadas na Gestação	Vacinas Contraindicadas na Gestação
• **dT (Dupla Adulto):** 3 doses (0-30-60d) se não imunizada. Completar esquema. • **dTpa (Tríplice Acelular): 1 dose em TODA gestação**, entre **20 e 36 semanas** (proteção contra coqueluche neonatal). • **Hepatite B:** 3 doses (0-30-180d) se suscetível (anti-HBs-). • **Influenza (Gripe):** 1 dose anual na campanha em qualquer idade gestacional. • **Covid-19:** Plataformas de vírus inativado ou mRNA. • **VSR (Vírus Sincicial Respiratório):** 1 dose entre 24 e 36 semanas (espaçar 15d da dTpa).	**CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA: Vacinas de Vírus Vivos Atenuados** pelo risco teórico de infecção fetal: • **Tríplice Viral (SCR - Sarampo, Caxumba, Rubéola)** • **Dengue** • **HPV** • **Varicela (Catapora)** *Observação:* Febre amarela e raiva com vírus atenuado só são aplicadas sob exposição de alto risco. Vacina antirrábica inativada é permitida.

Pré-Natal do Parceiro e Cronograma de Consultas de Baixo Risco:

• **Pré-Natal do Parceiro:** Inclui consulta clínica, atualização vacinal (dT, Hep B, Febre Amarela) e sorologias (HIV, Sífilis, Hep B e C, Tipagem sanguínea) para promoção da paternidade ativa e prevenção de infecções cruzadas.
• **Periodicidade das Consultas (Baixo Risco):**
- Até 28 semanas: Consultas **a cada 4 semanas (mensal)**.
- De 28 a 36 semanas: Consultas **a cada 2 semanas (quinzenal)**.
- De 36 a 40 semanas: Consultas **semanais**.
- De 40 a 41 semanas: Consultas **a cada 3 dias**.

6. CASOS CLÍNICOS PRÁTICOS E CONDUTAS DE PROVA

CASO CLÍNICO 1 (Datação e Naegele):
Paciente 26 anos, G1P0, DUM: 12/03/2026. Realizou USG transvaginal com 8 semanas mostrando CCN compatível com DUM (diferença de 2 dias).
• **Cálculo da DPP pela Naegele:** Dia: 12 + 7 = 19. Mês: Março (3) + 9 = 12 (Dezembro). Ano: 2026. **DPP = 19/12/2026.** Como a diferença do CCN foi < 5 dias, mantém-se a DUM oficial.

CASO CLÍNICO 2 (Suplementação de Alto Risco):
Paciente 31 anos, gestação planejada, possui filho prévio com Espinha Bífida e faz uso de Carbamazepina para epilepsia.
• **Conduta:** Paciente de altíssimo risco para Defeito do Tubo Neural (DTN). Prescrever **Ácido Fólico na dosagem de 4 mg/dia (ou 5 mg/dia)** a partir da consulta preconcepcional mantendo até a 12ª semana de gestação, retornando depois para a dose padrão de 400 µg/dia.

CASO CLÍNICO 3 (Gestante Rh Negativa):
Secundigesta, Rh negativo, parceiro Rh positivo. PAI / Coombs Indireto colhido na 1ª consulta veio NÃO REAGENTE.
• **Conduta:** Repetir o Coombs Indireto **mensalmente a partir da 24ª semana**. Ao atingir **28 semanas**, manter Coombs- e administrar 300 µg de **Imunoglobulina Anti-D** profilática.

CASO CLÍNICO 4 (Prevenção de Pré-Eclâmpsia):
Primigesta, 36 anos, IMC 32 kg/m², com baixa ingestão diária de laticínios.
• **Conduta:** Prescrever **AAS 100 mg/dia à noite** (da 12ª à 36ª semana) e **Carbonato de Cálcio 1,0 a 1,5 g/dia** (da 20ª semana até o parto, espaçado em 2 horas da tomada do ferro).

7. TABELAS DE MEMORIZAÇÃO RÁPIDA E RESUMO FINAL

Parâmetro Obstétrico	Regra Prática / Valor de Corte	Ponto Chave de Prova
Número Mínimo de Consultas	≥ **7 consultas**	Reduz em 7x o risco de óbito fetal vs ≤ 4 consultas.
Captação Precoce	**Até 12 semanas**	Marco inicial prioritário na Atenção Básica.
Regra de Naegele	**DUM + 7 dias / Mês - 3 ou + 9**	Ajustar por USG se diferença do CCN no 1ºT for ≥ 5 dias.
Ausculta Fetal (BCF)	**120 a 160 bpm**	Sonar Doppler: 10-11s | Pinard: 20-22s.
Alerta da Altura Uterina	**Divergência > 3 cm**	Indicação imediata de ultrassonografia.
TOTG 75g (24-28 sem)	Jejum ≥ 92 | 1h ≥ 180 | 2h ≥ 153	DMG se pelo menos 1 valor for igual ou superior.
Suplementação de Ferro	**40 mg ferro elementar/dia**	Mantido até o final da gestação em gestante não anêmica.
Ácido Fólico Especial	**4 mg/dia (ou 5 mg/dia)**	Se DTN prévio, anticonvulsivantes, DM1 ou IMC > 35.
Cálcio na Gestação	**1,0 a 1,5 g/dia (20s ao parto)**	Não é universal. Se alto risco de PE / baixa ingesta. Espaçar 2h do ferro.
Vacina dTpa	**1 dose entre 20 e 36 semanas**	Obrigatória em TODA gestação para profilaxia da coqueluche.

Parâmetro Obstétrico	Regra Prática / Valor de Corte	Ponto Chave de Prova
Vacina Contraindicada	**Vírus Vivos Atenuados**	Tríplice viral, Dengue, HPV e Varicela são proibidas.